外来でそのまま使える食事指導シリーズ

第10回 / 全10回

フレイル・多疾患併存の食事指導 — 制限よりも「守る」優先順位

シリーズ最終回 — 食事指導は「何を禁止するか」ではなく「何を守るか」

食事指導で最も難しいのは「病気が重なる患者」

各疾患の制限を足し算すると「何を食べてよいか分からない」状態に

- 糖尿病 ＋ 高血圧 ＋ 肥満
- 糖尿病 ＋ 腎臓病
- 腎臓病 ＋ 高齢 ＋ 体重減少
- 嚥下障害 ＋ 脱水 ＋ 低栄養
- 肝硬変 ＋ 筋肉量低下 ＋ 食欲低下
- がん術後 ＋ 下痢 ＋ 体重減少

制限がぶつかる典型例

糖尿病 ＋ 腎臓病
説明↑ →「ご飯もだめ、果物もだめ、肉もだめ」
→ 食べる意欲そのものが落ちる

高血圧 ＋ 低栄養
減塩で味を薄くしすぎ → 食事量がさらに落ちる
体重減少・筋力低下が前景にある場合は要注意

嚥下障害 ＋ 脱水
とろみ水が飲みにくい → 水分摂取量↓
誤嚥予防の代償で脱水・便秘・全身状態悪化

肝硬変 ＋ 筋肉量低下
必要以上の制限 → 全身状態をむしろ悪化させる
低栄養・筋肉量低下が大きな問題

まず優先すべきものは何か — 3つの順番

1 生命に直結する問題がないか

脱水・誤嚥リスク・著しい食事量低下・急速な体重減少・低血糖
LDLやHbA1cより先にここを見る

最優先

2 低栄養を進めないこと

体重減少→筋力↓→転倒→感染→入院→ADL↓
「この指導で食事量が落ちないか」を常に考える

重要

3 継続できること

独居・買い物困難・調理困難・家族と別メニュー不可
実行できなければ意味がない

基本

フレイル高齢者では何を守るべきか

数値の管理以上に「食べる力を保つ」「体重・筋肉量を落とさない」

- ⚖️ 体重減少がないか
- 😔 食欲低下がないか
- 🍚 主食だけに偏っていないか
- 🥩 たんぱく質源が毎食あるか
- 💧 水分は足りているか
- 🦷 嚥下や咀嚼に問題がないか
- 🛒 買い物や調理ができているか

「数値の改善」と「食べられること」のバランス

数値の改善だけを目標にすると全体を見失うことがある

HbA1cを下げるために	→ 食事量全体が落ちる
塩分を減らしすぎて	→ 食欲が低下する
腎臓を気にしすぎて	→ たんぱく質が不足する
嚥下に配慮しすぎて	→ 水分摂取が減る

数値＋食べられているか＋体重＋日常生活を一緒に見る

家族指導で伝えるべきこと

家族が熱心なほど「これもだめ、あれもだめ」になりやすい

- 完璧な制限食を目指さなくてよい
- まずは食事量を保つことが重要な場合がある
- 体重減少や食欲低下は見逃してはいけない
- 一度にすべてを変えなくてよい
- 食べやすい形で必要量を入れる工夫が大切

外来で使いやすい最終チェックポイント

1. 脱水や低栄養など急いで対応すべき問題はないか
2. 体重は減っていないか
3. 1日の総摂取量は確保できているか
4. たんぱく質源は毎日入っているか
5. 水分は足りているか
6. そのうえで塩分・糖質・脂質・カリウムの個別調整
7. 本人と家族が実行できる内容になっているか

この順番で考えると、制限の足し算に陥りにくくなる

よくある誤解

× 病気が多いほど制限を厳しくすべき

→ 制限の足し算は低栄養やフレイルを進める危険がある

× 数値が改善すれば食事指導は成功

→ 食事量↓や体重減少が起きていたら成功とは言えない

× 高齢者にも若年者と同じ制限を

→ 高齢者では制限しすぎが最も危険なことがある

シリーズ全10回を通じた原則

食事指導は「何を禁止するか」ではなく「何を守るか」を決めること

完璧な制限を目指すより
崩してはいけない土台を守る方が
臨床的に価値がある

まとめ — Key Takeaways

- ✓ 複数疾患では制限の足し算をしない
- ✓ まず生命に直結する問題を確認し低栄養・脱水を防ぐ
- ✓ フレイル高齢者では食べる力と体重・筋肉量を守ることが優先
- ✓ 数値改善と食べられることのバランスを常に意識
- ✓ 食事指導は「何を禁止するか」ではなく「何を守るか」

シリーズ全10回
ご視聴ありがとうございました

📋 再生リストから他の回もぜひご覧ください

👍 高評価・チャンネル登録よろしくお願いします

💬 コメント欄で質問・リクエストお待ちしています

外来でそのまま使える食事指導シリーズ